



Tudo o que dá para fazer aqui dentro

Cada fluxo do sistema, na ordem em que o trabalho acontece: do primeiro contato com o paciente até o plano na mão dele.

Este documento percorre o sistema na ordem do seu dia: o paciente que chega, a consulta que acontece, o plano que sai. Cada bloco é um caminho completo, do início ao resultado.

Uma decisão explica boa parte do que você vai ler: **o paciente não tem conta no sistema**. Ele recebe um link e lê o que você entregou — sem cadastro, sem senha, sem aplicativo para instalar. Tudo o que o sistema faz é feito por você, e o que chega ao paciente chega pronto.

Abrir a sua conta

O consultório inteiro nasce de um cadastro. Nada precisa ser configurado antes de começar a atender.

- 1 Você informa **nome, e-mail e senha**.
- 2 O sistema cria o consultório e o seu usuário como responsável.
- 3 A base de alimentos já vem carregada: **23.945 alimentos e 12.918 medidas caseiras**, prontos para prescrever.

Os dados do seu consultório são só seus. Nenhum outro consultório enxerga seus pacientes, seus planos ou seus alimentos cadastrados — a separação é verificada por teste a cada versão do sistema.

Trabalhar com a secretária

Quem marca consulta não precisa ver prontuário.

- 1 Você cadastra a pessoa com o perfil de **secretária**.
- 2 Ela entra com o login dela e trabalha na agenda e no cadastro de pacientes.
- 3 Você acompanha quem está ativo e desliga o acesso quando precisar.

Recuperar o acesso

Senha esquecida não vira chamado de suporte.

- 1 Na tela de entrada, você pede o link de recuperação pelo seu e-mail.
- 2 O link vale por **uma hora** e serve uma vez só.
- 3 Ao trocar a senha, qualquer sessão aberta em outro aparelho é derrubada.

Cadastrar o paciente

O cadastro mínimo é o nome. O resto entra quando você tiver.

- 1 Você cadastra **nome** e, se quiser, contato, data de nascimento e sexo.
- 2 A idade é calculada sozinha, e se atualiza sem você tocar nela.
- 3 A busca encontra por **nome, e-mail ou telefone**, sem se importar com acento ou maiúscula.

Já tem uma lista pronta? A importação por planilha traz todos de uma vez, aponta as linhas com problema e não deixa cadastro duplicado passar.

Enviar o questionário pré-consulta

Chegar à consulta com a leitura feita — é disso que se trata.

- 1 Você monta o questionário, ou parte do **modelo de pré-consulta** que já vem no sistema.
- 2 Gera o link para aquele paciente e o envia por onde já fala com ele.
- 3 O paciente responde **sem criar conta**, do celular, quando puder.
- 4 As respostas chegam ligadas ao paciente e ao atendimento marcado — sem redigitação.
- 5 O link aceita resposta **uma vez só**; depois disso ele não abre mais.

Questionário com pontuação é somado pelo sistema, e a classificação sai da faixa de corte do próprio instrumento. Se faltar resposta obrigatória, o score **não** é calculado — e o sistema diz qual resposta falta, em vez de entregar um número incompleto.

Marcar o atendimento

A agenda que impede o conflito antes dele acontecer.

- 1 Você escolhe paciente, data, hora, duração e o **tipo**: primeira consulta, retorno ou avaliação.
- 2 Se o horário se sobrepõe a outro atendimento, o sistema recusa e mostra qual é o conflito.
- 3 Você acompanha o dia ou a semana inteira, com o vão entre um atendimento e outro aparecendo como vão de verdade.

Ver a agenda no calendário que você já usa

Duas agendas viram uma.

- 1 Você gera um endereço de assinatura na tela da agenda.
- 2 Assina esse endereço no **Google Agenda**, **Apple Calendar** ou **Outlook**.
- 3 Eles passam a buscar sua agenda sozinhos: o que você marcar aqui aparece lá.
- 4 Se precisar cortar o acesso, gera outro endereço — o anterior deixa de funcionar na hora.

É um caminho de **mão única**: o que você marca aqui vai para o seu calendário, mas um evento criado lá não vira atendimento aqui.

Avaliação antropométrica

Você registra a medida; o sistema faz a conta e guarda como chegou nela.

- 1 Você lança **peso, altura e data**. O IMC sai calculado e classificado pela OMS.
- 2 Se medir **dobras cutâneas**, escolhe o protocolo e o sistema estima o percentual de gordura, com massa gorda e massa magra derivadas.
- 3 Se medir **circunferências**, sai a relação cintura-quadril com o risco sinalizado.
- 4 O **gasto energético** basal e total é estimado, e vai direto para a meta do plano alimentar.
- 5 A evolução entre avaliações aparece em série, para você enxergar tendência e não valor isolado.

Cada avaliação guarda **qual protocolo foi usado**. Se você mudar de protocolo daqui a um ano, a avaliação antiga continua dizendo como o número dela foi obtido — porque comparar estimativas de protocolos diferentes não é comparar.

Criança e adolescente

Criança não se avalia pela faixa de adulto.

- 1 Com a data de nascimento no cadastro, o sistema reconhece que é caso pediátrico.
- 2 A classificação sai por **escore-z das curvas da OMS**, e não pelas faixas de IMC de adulto.
- 3 Peso e estatura para a idade acompanham o crescimento ao longo das consultas.

As curvas são as tabelas oficiais da OMS, com **916 pontos de referência** carregados no sistema, por sexo e por mês de idade.

Gestante

O ganho esperado depende de onde ela começou.

- 1 Você registra o **IMC pré-gestacional** e a semana gestacional.
- 2 O sistema calcula a faixa de ganho esperada para aquele IMC de partida.
- 3 Cada consulta mostra se o ganho está abaixo, dentro ou acima do previsto.

Exames laboratoriais

O laboratório entrega o número; aqui ele vira leitura.

- 1 Você registra **parâmetro, valor, unidade e data da coleta**. O sistema traz um catálogo com 30 parâmetros usuais.
- 2 O valor é classificado contra a faixa de referência **daquele sexo e daquela idade**.
- 3 Você anexa o laudo em arquivo, e ele fica junto do resultado.
- 4 A série histórica de um parâmetro mostra a evolução entre coletas.
- 5 A solicitação de exames que você pediu também fica registrada.

O resultado guarda **a faixa de referência que foi usada** na classificação. Se a referência mudar depois, o exame antigo continua contando a leitura que você fez na época — e não uma releitura silenciosa.

Montar o plano alimentar

Refeição por refeição, com a conta acontecendo enquanto você monta.

- 1 Você cria as refeições do dia, cada uma com **nome e horário**.
- 2 Busca o alimento e escolhe a **medida caseira** — colher de sopa, xícara, unidade — ou o peso em gramas.
- 3 Os totais de energia, proteína, carboidrato e gordura somam **por refeição e por dia**, enquanto você monta.
- 4 A distribuição entre macronutrientes aparece em percentual.
- 5 O prescrito é comparado com a **meta energética** que veio da avaliação.

Quando um alimento não tem determinado nutriente medido na tabela de origem, o total é marcado como **parcial**. O sistema nunca trata dado ausente como zero — a diferença entre "não tem" e "não foi medido" é justamente o que faz um total mentir.

Encontrar o alimento certo

Três bases que se completam, numa busca só.

- 1 Você digita e a busca ignora acento e maiúscula, ordenando por **relevância clínica** — não em ordem alfabética.
- 2 Filtra por grupo de alimentos ou por fonte, se quiser estreitar.
- 3 Cada alimento mostra **de onde o dado veio**: TACO, IBGE/POF ou rótulo do fabricante.
- 4 Para industrializado, a busca por **código de barras** chega direto no produto.

Cadastrar o que é seu

As tabelas de referência são um ponto de partida, não uma camisa de força.

- 1 Você cadastra **alimentos próprios** do consultório, que só você enxerga.
- 2 Cria **porções próprias** sobre qualquer alimento, inclusive os das tabelas oficiais.
- 3 A sua porção tem precedência sobre a do acervo na hora de prescrever.

As tabelas de referência não são editáveis, e isso é proposital: elas são acervo compartilhado, e alterá-las mudaria o dado para todo mundo. Quem quer mudar, cadastra a versão própria.

Montar uma receita

"Arroz com brócolis" prescrito uma vez, usado sempre.

- 1 Você combina alimentos como **ingredientes** e informa o rendimento da preparação.
- 2 A composição é calculada a partir dos ingredientes e do rendimento real.
- 3 A receita passa a aparecer na busca e a ser prescrita **como qualquer alimento** — com medida caseira e tudo.
- 4 Uma receita pode ser ingrediente de outra: um refogado dentro de uma torta.

O rendimento é informado por você e não somado dos ingredientes, porque 100 g de arroz cru viram cerca de 250 g cozido. Somar os ingredientes daria uma composição duas vezes e meia mais concentrada que a realidade.

Prescrever com flexibilidade

Nem todo plano se escreve em gramas.

- 1 Você oferece **substituições** para cada item: o paciente escolhe entre equivalentes.
- 2 Ou prescreve de forma **qualitativa**, sem quantificar, quando é isso que o caso pede.
- 3 Salva o plano como **modelo** e reaproveita a montagem no próximo paciente parecido.

Anexar as orientações

A explicação que você já escreveu uma vez, entregue de novo.

- 1 Você mantém uma **biblioteca de orientações** do consultório, e o sistema já traz cinco modelos prontos.
- 2 Anexa ao plano, e pode **adaptar o texto para aquele paciente** sem alterar o seu modelo.
- 3 Acrescenta uma **figura** — o prato dividido, uma lista de compras desenhada — que vai junto no link e no impresso.

O texto entregue é **congelado no momento do anexo**. Se você corrigir o modelo daqui a seis meses, o plano que o paciente já recebeu continua dizendo o que dizia. Nada que foi entregue muda sozinho.

Publicar e enviar o link

O paciente abre no celular, sem instalar nada e sem criar conta.

- 1 Enquanto o plano é **rascunho**, o link não abre para ninguém — trabalho em andamento não vaza.
- 2 Você publica, e o sistema gera o endereço do plano.
- 3 Envia o link por onde já conversa com o paciente.
- 4 Ele abre e lê: refeições em ordem de horário, com a medida caseira em destaque e as substituições ao lado.
- 5 Se precisar cortar o acesso, você **gera outro link** e o anterior para de funcionar.

Imprimir o plano

O impresso é o único que funciona na cozinha sem bateria.

- 1 Um botão gera o **PDF** do plano, pronto para imprimir ou anexar em e-mail.
- 2 A folha se basta: traz o consultório, o seu nome, o CRN e a vigência do plano.
- 3 As orientações e as figuras saem junto, depois das refeições.
- 4 Rascunho também imprime — carimbado como rascunho, para você conferir antes de publicar.

No impresso, a **medida caseira aparece em corpo maior** que o nome do alimento. O paciente já sabe o que é arroz; o que ele não sabe é quanto.

Fechar o atendimento

Histórico verdadeiro do acompanhamento, e não só do que foi marcado.

- 1 Você marca o atendimento como **realizado, cancelado ou falta**.
- 2 A falta fica no histórico do paciente.
- 3 O horário cancelado volta a ficar livre na agenda.

Acompanhar a evolução

O retorno começa sabendo o que mudou.

- 1 A ficha do paciente reúne **avaliações, exames, planos e atendimentos** em ordem.
- 2 As medidas aparecem em série, comparáveis entre si.
- 3 O plano anterior vira ponto de partida do próximo, sem remontar do zero.

O financeiro do consultório

Saber quanto entrou, quanto falta entrar e de quem.

- 1 Você registra **receitas e despesas**, ligando o lançamento ao paciente e ao atendimento.
- 2 Acompanha a situação de cada um: **pendente, pago ou cancelado**.
- 3 Apura o resultado do período.
- 4 Consulta a lista de **inadimplência**, com quem está devendo e desde quando.
- 5 Emite o **recibo** do atendimento.

O paciente não tem conta, não instala aplicativo e não preenche diário alimentar. Ele faz duas coisas, e as duas por link:

- 1 **Lê o plano que você entregou** — refeições, medidas caseiras, substituições, orientações e figuras. Abre no celular, e continua abrindo depois.
- 2 **Responde o questionário pré-consulta**, uma vez, antes de vir.

Isso é escolha de projeto, não falta. Sistema que exige adesão do paciente cobra do nutricionista o trabalho de conseguir essa adesão — e o plano que o paciente não abre é o plano que não existe. Aqui, o que chega até ele já está pronto, e o esforço de abrir é um toque no link.

O que o sistema não faz

Tão importante quanto a lista anterior. Cada ausência abaixo é uma decisão, e vale saber dela antes e não depois.

Aplicativo do paciente	Não existe, e não está previsto. O paciente lê pelo link, no navegador que já tem.
-------------------------------	--

Diário alimentar	O paciente não registra o que comeu. O sistema é ferramenta do nutricionista.
-------------------------	---

Conversa por dentro do sistema	Você continua falando com o paciente por onde já fala.
---------------------------------------	--

Envio automático de e-mail	Os links de plano e de questionário são gerados aqui e enviados por você.
-----------------------------------	---

Evento criado no seu calendário	A agenda vai daqui para o seu calendário, e não de volta.
--	---

Emissão fiscal	O financeiro apura o resultado e emite recibo; nota fiscal fica fora.
-----------------------	---

Três regras atravessam o sistema inteiro, e valem mais que qualquer funcionalidade da lista: **o registro guarda o que se sabia quando ele foi feito** — o peso prescrito, o protocolo da avaliação, a faixa do exame, o texto da orientação; **dado que não foi medido fica em branco, nunca em zero**; e **o que foi entregue ao paciente não muda sozinho**.